Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2024-2025

CORRECTION

Examen Blanc nº 1 PASS
UE 7 : SHS



Durée de l'épreuve : **1h30**

A LIRE AVANT DE COMMENCER L'EPREUVE

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom, et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices ne sont pas autorisées.
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES À L'ÉPREUVE

INFORMATIONS SUR L'ÉPREUVE

Le sujet contient 8 pages numérotées de 1 à 8 et comporte 1 QROC et 1 commentaire.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Mot des RMs

Coucouuuuu mes stars, j'espère que vous allez bien et que ce premier sujet de Tuto vous a été utile. Déjà félicitations d'être venu faire de la SHS de bon matin, ce n'est pas forcément évident mais ça en vaut la peine (et j'ai été trop content de tous vous voir ;)).

Ensuite, c'est le tout premier entraînement en conditions réelles que vous réalisez donc c'est normal de ne pas tout savoir et d'avoir été un peu perdus. Vous allez voir, vous allez énormément progresser tout au long du semestre. D'ailleurs, regardez bien la correction que vous trouverez dans ce poly, ça va vous aider à comprendre un peu ce qu'on attend de vous. Mais attention, la correction qu'on vous propose N'EST PAS LA SEULE POSSIBLE. Il existe pleins de QROC et de commentaires pour chaque sujet, le but étant d'y faire figurer les informations importantes, mais à vous de voir l'agencement que vous voulez faire.
De plus, aidez-vous de la grille de correction que chaque tuteur vous a personnalisée en fonction de votre copie, c'est votre support indispensable pour comprendre votre note et ne plus refaire d'erreurs de méthodo par exemple. Et si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir nous en parler que ce soit sur le forum ou au bureau, on se fera un plaisir de vous répondre.

Niveau difficulté, le sujet était conçu pour être très représentatif de ce qu'on vous demande le jour J. La QROC est assez précise mais demande tout de même de bien synthétiser pour pouvoir la faire en 10 lignes. Le commentaire quant à lui nécessite à la fois de s'appuyer sur le texte et de citer son cours, quoi de mieux finalement ;).

Maintenant que tout ça est dit, je vous souhaite une bonne correction de la meilleure épreuve que vous ayez eue (oui oui faites-moi confiance) 😉 et n'oubliez pas que vous êtes des boss !!!!

Gros bisousssss les P1
Killian, votre CanguilhRM

QROC : Afin d'illustrer les enjeux de la bactériologie au XIXe siècle, vous expliquerez la controverse sur la génération spontanée et nommerez les 2 acteurs principaux. (10 lignes)

Correction de la QROC :

Dans les années 1860, la théorie sur la génération spontanée, selon laquelle de la matière inorganique peut donner naissance à de la matière organique, fait fortement débat. Pour trancher sur la question, l'Académie des Sciences lance un concours de prix. Il ne s'agit pas là d'une affaire de médecine mais plutôt d'une affaire d'expérimentation. Pasteur et Pouchet s'opposent dans ce débat. Dans son expérience, Pouchet fait bouillir une infusion de foin pour tuer les micro-organismes, puis place le liquide dans un récipient pensé hermétique. Des micro-organismes se développent, c'est selon lui, la preuve de la génération spontanée. Pasteur le contredit avec son expérience dans un ballon à col de cygne, qui montre que les micro-organismes de Pouchet proviennent de l'extérieur et que le récipient n'était pas hermétique. Les faits ont tranché, c'est le triomphe de la méthode expérimentale de Pasteur.

Les points soulignés sont vraiment très importants et doivent apparaître sur votre copie.

COMMENTAIRE DE TEXTE :

Cette partie est à rédiger sur la copie commentaire de texte, dans l'encart prévu. Merci de ne pas rédiger vos réponses au feutre, ce qui rend la copie quasi impossible à lire et donc à corriger.

La décennie quatre-vingt-dix aura été marquée par un changement important de la gestion des systèmes de santé. Ce changement résulte de la prise de conscience, dès la fin des années quatre-vingts, des nouvelles donnes du paysage sanitaire : avancées médicales, pression des problèmes de santé publique, attentes des usagers. L'orientation vers un nouveau modèle de régulation s'impose progressivement. Elle se fonde sur la nécessité de définir les différentes compétences susceptibles d'intervenir et de situer leurs rôles dans la gestion globale du système. L'accent est placé sur l'expertise. Ce processus rend compte du rôle de plus en plus important de l'épidémiologie en matière d'aide aux processus décisionnels. Parallèlement se posent des questions de synergie entre experts et décideurs. Expertise et stratégie constituent les deux pôles des nouveaux processus de gestion mis en œuvre. Cette synergie se révélera porteuse de projets innovants en matière de gestion du système de santé. La conception des dispositifs sera lente. Quel type de structure mettre en œuvre ? Quel type de relations introduire entre institutions d'expertise et administration ? [...]

Après quelques années, le statut d'établissement public d'État est choisi (les organismes garderont cependant la dénomination d'« agences sanitaires »). Cette option était significative d'une volonté de situer la responsabilité de l'État vis-à-vis des dispositifs mis en place tout en conservant une distance institutionnelle entre agences et administrations. Cette dernière se centrera sur la stratégie et la décision, les agences sur la veille et l'expertise. [...] Deux catégories d'agences ont été constituées. Leurs origines sont distinctes, les contextes dans lesquels elles ont émergé également. Cependant elles correspondent à une même volonté d'opérer une certaine distance vis-à-vis de la tutelle dans un objectif de plus grande opérationnalité.
Les unes, agences sanitaires, répondent à la nécessité de développer dans le champ de la santé publique l'expertise épidémiologique afin de prendre en compte les nouvelles donnes du paysage sanitaire et de répondre ainsi aux attentes des usagers. Il s'agit ici de distinguer deux fonctions, celle de la stratégie relevant de l'État, celle de l'expertise relevant des agences. Les autres se situent dans le cadre d'une délégation de gestion et exercent leurs activités à l'échelon déconcentré de la région. [...] Leur distance vis-à-vis de la tutelle n'est pas identique à celle instaurée par les agences sanitaires.

Source : Les agences dans le système de santé : un nouveau paysage institutionnel ? Les agences : topologie et missions. ADSP Actualité et dossier en santé publique (n° 37, décembre 2001), Jean-François Girard ; Antoinette DESPORTES-DAVONNEAU ; Marc Duriez

D'après ce texte et vos connaissances, vous expliciterez le processus d'apparition des agences puis vous détaillerez les différents types et fonctions de celles-ci.

Correction du commentaire

Les années quatre-vingt-dix ont été pour le système de santé synonymes de crises sanitaires et de grands tournants. Pendant cette période historique, plusieurs scandales sanitaires, comme celui de la vache folle ou du sang contaminé, ont poussé le système de santé à évoluer et à se réorganiser. Les agences de santé sont dès lors mises en place, dans le but d'apporter une nouvelle approche de la régulation du système. Lors de leur apparition, ces dernières obtiennent divers rôles et, de ce fait, n'agissent pas à la même échelle. C'est de ces nouvelles institutions que nous parlent Jean-François GIRARD, Antoinette DESPORTES-DAVONNEAU et Marc DURIEZ à travers cet article à visée historique *Les agences un nouveau paysage institutionnel ? Les agences : topologies et missions,* tiré du journal *ADSP actualité et dossier en santé publique*, paru en décembre 2001. À travers cet article, les trois auteurs nous expliquent le processus de mise en place des agences ainsi que l'existence de deux types d'agences détaillant leurs fonctions et leurs différences. Nous allons nous demander dans un premier temps dans quel contexte ont été créées les agences et ce qu'elles apportent de nouveau au système de santé, puis nous nous questionnerons sur la nature des différences entre les deux types d'agences mises en avant par les auteurs.

Dans un premier temps, remontons à l'époque de la fameuse « décennie quatre-vingt-dix » (ligne 1) durant laquelle de nombreux scandales éclatent. Nous pouvons alors prendre l'exemple du scandale du sang contaminé, au cours duquel de nombreux patients, souvent hospitalisés, furent contaminés par le VIH ou l'hépatite C. Cette crise sanitaire prend alors place dans un contexte où des « problèmes de santé publique » (ligne 4) comme le SIDA ont émergé au cours des années quatre-vingt. En effet, durant ces années, les mesures de sécurité sanitaire n'étaient que trop peu efficaces, voire inexistantes. Les années quatre-vingt-dix sont alors un réel moteur dans « L'orientation vers un nouveau modèle de régulation » (lignes 4 et 5) qui se solde par l'apparition des agences sanitaires. Nous pouvons par exemple lier l'apparition de l'Agence Française du Sang (AFS) à la crise du sang contaminé. En outre, nous pouvons alors associer la première et principale phase d'apparition des agences de santé à une réponse aux crises et scandales sanitaires. À noter qu'une seconde phase a lieu sans lien direct avec des conséquences événementielles critiques (c'est par exemple lors de cette phase qu'apparaît le réseau national de santé publique).

Par la suite, les auteurs mettent en avant l'idée que désormais, le système de santé est composé de « différentes compétences susceptibles d'intervenir » (lignes 5 et 6). Cela marque ainsi l'apparition d'une nouvelle répartition des rôles dans la régulation du système de santé, composé de plusieurs pôles devant alors coopérer pour gouverner la santé. Ainsi, ces derniers expliquent que « l'accent est placé sur l'expertise » (ligne 7) c'est-à-dire sur le fait de mener une observation et d'évaluer une situation : c'est le rôle principal que prennent les agences. Ces dernières apparaissent alors comme une institution objective, apportant un point de vue assez global des circonstances, prenant ainsi en compte tous les détails et le contexte actuel, comme une certaine vue de haut du système de santé. En effet, les agences constituent alors le néo-pôle de la régulation du système de santé, celui de la régulation externe de la profession. Cette fameuse régulation externe permet alors à l'action publique de s'appuyer sur l'expertise des agences avant de prendre une décision. En effet, cette nouveauté, mettant alors l'accent davantage sur l'importance de l'expertise et le recul dans la prise de décision en santé s'oppose à

la régulation interne, seule régulation en place jusque-là. Cette dernière est menée par les ordres de santé eux-mêmes, et ce n'est donc pas vraiment synonyme d'objectivité. Les auteurs explicitent alors ce changement à la ligne 8 : « du rôle de plus en plus important de l'épidémiologie en matière d'aide aux processus décisionnels ».

En outre, l'article met alors en avant une nouvelle question stratégique naissante : comment concilier expertise et décision ? L'intime liaison entre ces deux nouveaux pôles est notamment mise en évidence par les questions que l'on pourrait interpréter comme rhétoriques, aux lignes 12 et 13, en particulier cette dernière : « Quel type de relations introduire entre institutions d'expertise et administration ? ». Il va de soi que cette période fait face à la nécessité d'une nouvelle entente, qui est alors davantage prononcée lorsque les agences sont reconnues nationalement : « Après quelques années, le statut d'établissement public d'État est choisi » (ligne 14). Le questionnement sur la place et la bonne répartition des rôles prend désormais une tournure étatique. De fait, les auteurs expliquent que le rôle de la nouvelle institution instaurée sera centré « sur la veille et l'expertise » tandis que celui de l'État, plutôt sur « la stratégie et la décision ». On connaît alors un passage d'un État tutélaire à un État administratif, décisionnaire et qui délègue certaines responsabilités à des acteurs dont les compétences sont reconnues. La stratégie mise en place se solde alors par une pluralité des institutions gouvernant la santé, permettant alors de séparer expertise et décision, tout en essayant de les concilier. Ainsi on se retrouve maintenant avec des acteurs qui sont désormais beaucoup plus compétents dans leur propre domaine, permettant alors une gestion du système de santé bien plus efficace, sécurisée et qualitative.

Maintenant que nous avons pu définir les rôles et les limites des agences, portons notre attention, plus en profondeur, sur l'organisation de ces institutions elles-mêmes.

Dans un premier temps, il nous est possible de remarquer que dès la ligne 19, les auteurs nous expliquent que « deux catégories d'agences ont été constituées ». Ces deux types d'agences diffèrent sur un bon nombre de points, mais gardent un objectif commun : « Cependant elles correspondent à une même volonté » (ligne 20). D'une part, les auteurs nous décrivent un premier type d'agences, à savoir les agences de « mission de veille et de sécurité sanitaire ». Elles sont en quelque sorte celles apparues lors de la première phase, pour répondre aux crises sanitaires. D'autre part, les auteurs évoquent les agences « de gestion des activités de santé », qui elles sont apparues plus tardivement, au cours d'une seconde phase. C'est le cas de la Haute Autorité de Santé. Ces deux types d'agences diffèrent alors grandement l'une de l'autre tout d'abord par leur chronologie d'apparition. En effet, les agences de mission de veille et de sécurité sanitaire sont une réponse directe aux scandales des années quatre-vingt-dix, pour lesquelles nous pouvons prendre l'exemple de l'AFS, tandis que les agences de gestion des activités de santé sont apparues lors d'une seconde phase, plutôt organisationnelle, ne répondant donc pas directement à une crise actuelle, ni à la nécessité d'aider l'État ou à prendre une décision de santé publique.

Par la suite, une différence majeure se joue dans le rôle de ces agences, les unes ayant pour rôle « l'expertise ». Elles sont impliquées dans l'aide à la prise de décision par l'État lorsqu'il est question de problèmes de santé publique afin de « répondre ainsi aux attentes des usagers » (ligne 25) ; et les autres, ayant un rôle de gestionnaires. Une seconde différence intrinsèque à la précédente concerne la distance vis-à-vis de l'État. En effet, les agences sanitaires dans l'expertise sont clairement distancées de l'État : « Il s'agit ici de distinguer deux fonctions, celle de la stratégie relevant de l'État, celle de l'expertise relevant des agences »

(lignes 23-24), alors que les agences gestionnaires, d'après les auteurs, le sont nettement moins : "Leur distance vis-à-vis de la tutelle n'est pas identique à celle instaurée par les agences sanitaires » (ligne 27).

Enfin, la dernière différence notable entre les deux types d'agences repose sur le périmètre d'action. Effectivement, les agences sanitaires d'expertise travaillent, bien qu'elles soient tenues à distance, à un niveau national afin d'aider et d'apporter un œil objectif aux décisions de santé publique. En opposition à ces dernières, les agences gestionnaires, comme le souligne les auteurs, travaillent alors à « un échelon déconcentré de région » (ligne 26), ce qui signifie ici qu'elles permettent de mettre en œuvre des politiques pourtant nationales à une échelle territoriale, ou dans le cas ici présent, à un domaine précis. On peut alors prendre comme illustration l'agence de la biomédecine. Leur activité, en termes de périmètre diffère alors grandement. En somme, là où certaines agences sont centrées sur l'action et la réaction lors d'un problème sanitaire d'ampleur publique, nécessitant une prise de décision, d'autres exercent un rôle beaucoup plus centré sur un domaine assez précis, loin d'un contexte d'urgence et de scandale sanitaire.

En conclusion, les scandales sanitaires ayant éclaté dans les années quatre-vingt-dix ont poussé le système de santé à se réorganiser, donnant alors naissance aux agences sanitaires. Ces dernières permettent de garantir une séparation des pouvoirs d'expertise d'une part et de décision d'autre part, afin de travailler avec des acteurs chacun très compétent dans leur domaine. Cependant, ce n'est pas le cas de tous les types d'agences puisque certaines existent plutôt dans le but de répondre à une question d'organisation et de gestion du système. La sécurité et la qualité sont alors les mots d'ordre de cette réorganisation. Encore aujourd'hui, il nous est possible de voir l'importance des agences, comme Santé Publique France, qui ont eu un rôle majeur d'information, et d'évaluation dans la crise sanitaire du coronavirus dès 2019.

Ce sujet a été réalisé par :

Rédacteurs : Killian MADEJ (DFGSM2, RM SHS EB PASS 2024-2025), Andréane PIERZO (DFGSM2), Iness BOUZIANE (L.AS 2 Éco gestion)

Relecteurs : Morane EBELET (DFGSM2), Killian MADEJ (DFGSM2, RM SHS EB PASS 2024-2025)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :
Tamina MOUHAMED (DFGSM2) et Lisa GRILO SANTOS (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la** Secte Hyper Sexe

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université

Sous la coordination de Valentine PAILLARD (DFGSM3, RM SHS EB PASS 2023-2024), Camille KLAPISZ (DFGSM3, RM SHS GT PASS 2023-2024), Killian MADEJ (DFGSM2 RM SHS EB PASS 2024-2025) et Simon COMMENAY-LE ROUX (DFGSM2 RM SHS GT PASS 2024-2025)

Prenez votre copie en photo avant de la rendre.
Votre note et classement sont disponibles sur le site ***www.a2sup.fr***
Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre copie sur l'adresse suivante:
grilles@a2sup.fr

A2SUP forum

L'A2SUP répond à toutes vos questions sur le forum : forum.a2sup.fr

⚠️Les bases du forum⚠️

Question de cours : Titre du cours Photo/Diapo/Figure/Paragraphe Question	Utiliser la **loupe** (en haut à droite) Chercher le bon topic	**Question Exos/Annales :** QXX (mettre les 2 chiffres ex : Q03) Énoncé Question

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP